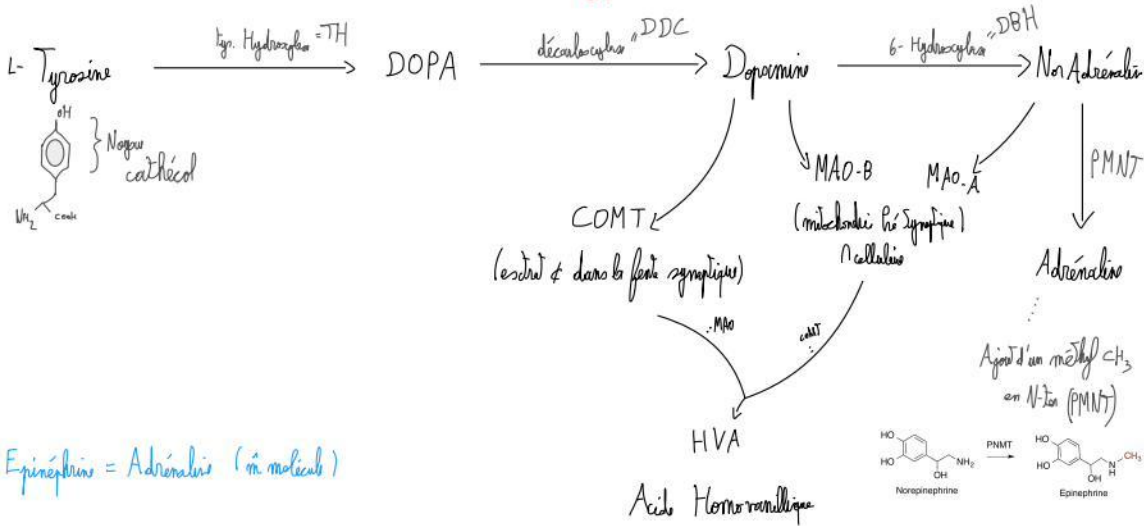
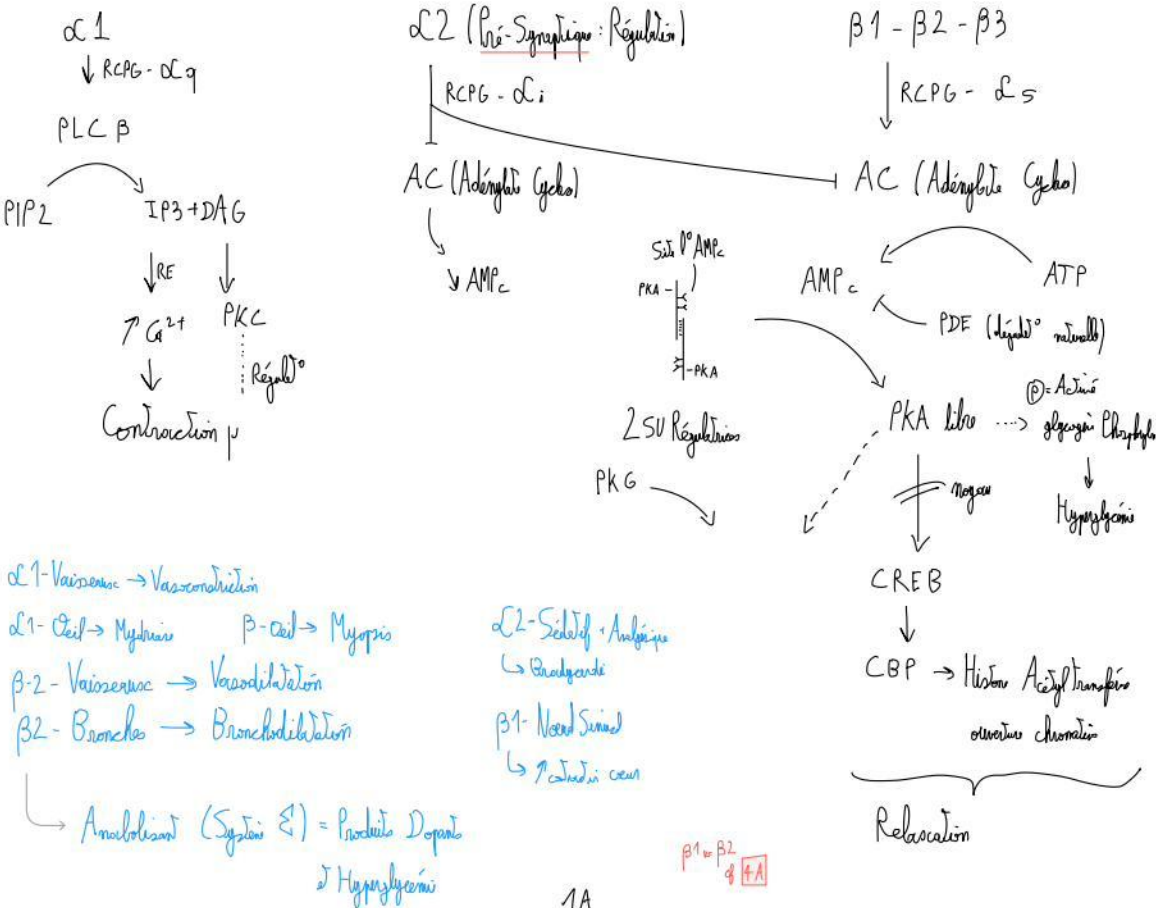


\$ Catécholamines

Domaines Adrénorécepteurs



Traitement Parkinson: L-Dopa + I° Dopa qui ne franchit pas la BHE $\rightarrow$ dégrade la Dopa en pré-dopa



Medicaments Adrénérgiques

Adrénaline

$\alpha + \beta_1 + \beta_2$ stimulants

(IV) $\rightarrow$ Tissu Périphérique
ne franchit pas la BHE

(I°) $\rightarrow$ MAO & COMT

(doses) $\rightarrow$ Trois courts

Vasodilatation + Bronchodilatation
+ Hypotension

Chronotrope Positif β_1
+ Inotrope Positif β_1
+ Bâthmotrope Positif β_1
+ Dromotrope Positif β_1

Vasoconstriction + Mydriase

Non Adrénaline

$\alpha_1 + \beta_1$ Stimulants

Réponse à la dose
si cœur intact
Vasoconstriction général

(Indic°) $\rightarrow$ choc &
arrêt

(EI) : Nœvus cutanés
Contractures ++
Ischémie

gène respiratoire
Tachycardie

Réaction Allergique au Metabisulfite de Sodium (conservation)

Isoprénaline = isoprotérénol

β_1 & β_2 Stimulants (Trois β Stimulants)
Vasodilatation

Touche surtout le cœur (Chronotrope, inotrope...)

Travail + = - résistances périphériques (Vasodilatation)

Dobutamine = Dobutrex

β_1 Stimulant

Agit que sur le cœur, sans changement périphérique

(IV) $\rightarrow$ Voie Parentérale (pas d'absorption intestinale)

(INDIC) $\rightarrow$ Pas de choc (réponse à la dose)

(EI) $\rightarrow$ Anger

(Indic°) En cas de Bradycardie Sévère

Dopamine

Faible dose : Vasodilatation D_1

Moyenne dose : Vasodilatation D_1 & β_1 + Cœur β_1

Haute dose : Vasoconstriction α

	RECEPTEURS ADRENERGIQUES		
	α_1	β_1	β_2
ADRENALINE	++	+++	+++
NORADRENALINE	+++	+	0
DOBUTAMINE	0	+++	+
ISOPRENALINE	0	+++	+++
DOPAMINE	++ 3	++ 1	++ 1 (D ₁)

Vasoconstriction

Cœur Stimulé

Vasodilatation

Antihypertenseurs d'action centrale

Agoniste α_2 Pré-synaptique



Rétrocontrôle central (bulbe rachidien)



↓ Tonus Σ global



Tris efficaces = **EE** Sédatifs / Hypotenseurs

=

- Sédatif

← Clonidine →

← Rimézanil →

Agoniste I_1 (R-Imidazoline)



↓ Excitabilité Neurone Σ



↓ E_{JPA} & ↑ Tonus Végétal PE



Motiv = Bénédicte

=

+ Sédatif

Agoniste β_2

Vasodilatation → Systémique ou Local (Bronchodilatateur, Utérin Relaxant) + Hypoglycémie

} Anabolisant = dopage

Action cardiaque (4-6h)

Salbutamol

Action Prodrigue (12h)

"- Laxol"

salméterol en cas d'Asthme nocturne

Amphétamines = Sympathomimétiques INDIRECT

Trois lipophiles, ils passent la BHE → Forêt Sympathique

Anti-Dépresseur Tricyclique / isoméris

I° Récepteur NET (Norépinéphrine Transporter) → Amplifié la Stimulation Mais Anticholinergique
DAT (Dopamine Transporter)
SERT (Sérotonine Transporter)

MAO

I° dégradation MAO ou COMT

Anti-dépresseur I° de MAO

△ Alimétil I° Paroie on Tyrosine!

corne → Anti-dépresseur
Foie → Surcharge Tyrosine → Grosse HTA "cheese effect"

Syndrôme Sérotoninergique

Accumulation Sérotonine → Stimulé 5-HT_{1A} 5-HT₂

Aliment → Tyrosine
↓
Stimule Sécrétion Noradr.
↳ et 1 Séro = HTA
MAO (inhibiteur/fonct)

Antagoniste Système Adrénérgique

β -Blocant



$\beta_1 + \beta_2$

↓ Touché car peu sélectif : Bronchoconstriction / Hypoglycémie / Vasodilatation ... (EI)

Agonisme partiel

↳ Trop Stimulé = Antagoniste

↳ Peu Stimulé = Agoniste

↳ Anticardiotonique + limite la bradycardie

⋮

dim. Tolérance à l'effort (EI)

↳ I^e cellule à Rénine β_1 adré → AntiHypertension

↳ dim. pression intra oculaire (glaucome)

Activité Sympathomimétique Intrinsèque (AI) = Agonisme Partiel

Suffixe "-ol" Acébutolol

Bisoprolol

(Contre INDC) S^e Raymond

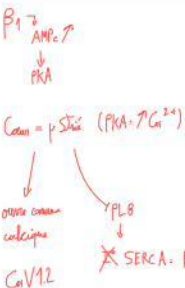
Antagoniste L1 Sélectif



I^e Source de Ca^{2+} → Vasodilatation et VPA
Surtout Urinaire

Suffixe en "-azine" Carbazepine

(INDC) Hypertrophie Prostate → Rétention
↓
Chirurgie



PLB ↓
SERCA: Pompe qui recharge le RE en Ca^{2+}

Relaxation + hypotension
Mais provoque constriction + frot

